

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	INFECTION RISK ASSESMENT RENOVATION (ICRA) BANGUNAN		
	No. Dokumen 935.81/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.
Pengertian	Penilaian yang dilakukan terhadap kontrol infeksi oleh TIM PPI bila ada rencana perbaikan, renovasi, dan pembangunan baru atau pembangunan kembali bangunan yang ada di rumah sakity, yang memungkinkan terjadinya infeksi bagi pasien, bekerja dan orang yang beraktivitas di rumah sakit. Rekomendasi dari TIM PPI sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi akibat aktivitas pembungan tersebut	
Tujuan	Menjadi pedoman dalam menilai resiko infeksi yang dapat terjadi akibat debu pembungan baru atau perbaikan gedung di rumah sakit	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	1. Managerian RS menginformasikan kepada TIM PPI tentang rencana pembangunan / renovasi gedung rumah sakit 2. Tim menganalisa dampak pembangunan terhadap lingkungan rumah sakit dengan menggunakan langkah-langkah ICRA (terlampir) 3. Telaah ICRA menghasilkan rekomendasi dari TIM PPI kepada Tim kontruksi atau renovasi bangunan 4. Bila tim konstruksi / renovasi bangunan menyetujui rekomendasi tim PPI maka Tim PPI, dan tim kontruksi dan renovasi menandatangani format kesepakatan pengendalian infeksi dampak kontruksi dan renovasi bangunan 5. Pembangunan dapat dilanjutkan bila tim kontruksi dan renovasi bangunan telah melaksanakan rekomendasi tim PPI 6. Tim PPI bersama manajemen rumah sakit mengawasi jalannya pekerjaan kontruksi atau renovasi bangunan 7. Bila dalam pekerjaannya tim kontruksi / renovasi bangunan tidak menjalankan rekomendasi yang dianjurkan tim PPI, maka pihak manajemen dapat meninjau kembali izin pelaksanaan kontruksi / renovasi bangunan tersebut	
Unit Terkait	ALL Unit di Rumah Sakit RS Prima Husada Sukorejo Komite PPI Komite K3RS	

Lampiran

ICRA Renovasi Bangunan

1. Izin ICRA

1.	No. Kajian	
2.	Nama Proyek	
3.	Lokasi Proyek	
4.	Tanggal kajian	
5.	Petugas yang melaksanakan kajian	
6.	Verifikasi oleh	

2. Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek

Tabel 10.1 Klasifikasi Jenis Konstruksi

TIPE	AKTIVITAS / KEGIATAN
TIPE A	Pemeriksaan dan kegiatan pemeliharaan umum 1. Mengganti ubin, langit-langit (plavon) untuk inspeksi visual saja. Misalnya : terbatas pada 1 genting/plafon per 50 meter persegi 2. Pengecatan (tidak pengamplasan) 3. Wall covering, pekerjaan Listrik, pipa kecil, dan kegiatan yang tidak menghasilkan debu atau memerlukan pemotongan dinding atau akses ke langit-langit selain untuk pemeriksaan yang kelihatan
TIPE B	Skala kecil, kegiatan jangka pendek, yang menghasilkan sedikit debu : 1. Instalasi telepon dan perkabelan computer 2. Akses keruang terbuka 3. Pemotongan dinding atau langit-langit dimana migrasi debu dapat terkontrol
TIPE C	Pekerjaan yang menghasilkan debu Tingkat sedang hingga Tingkat tinggi atau memerlukan pembongkaran atau pemindahan/penghapusan dan pembersihan komponen bangunan tetap atau rakitan : 1. Pengamplasan dinding untuk pengecatan atau pelapisan dinding 2. Pemindahan/penghapusan/pembersihan penutup lantai, plafon langit-langit dan pekerja khusus 3. Konstruksi dinding baru 4. Pekerjaan saluran kecil atau pekerjaan Listrik diatas langit-langit 5. Kegiatan kabel utama 6. Kegiatan apapun yang tidak dapat diselesaikan dalam shift kerja Tunggal
TIPE D	Pembongkaran dan kontruksi proyek-proyek besar 1. Kegiatan yang membutuhkan shift kerja berturut-turut 2. Penghancuran mayor dari proyek bangunan 3. Memerlukan pembongkaran berat atau pemindahan/penghapusan system perkabelan lengkap 4. Konstruksi baru

3. Identifikasi kelompok risiko pasien

Jika lebih dari satu kelompok risiko akan terpengaruh, pilih grup yang lebih tinggi. Untuk semua kelas konstruksi, pasien harus dipindahkan dari ruangan sementara pekerjaan dilakukan.

Tabel 10.2 Klasifikasi Kelompok Risiko

Resiko Rendah	Resiko Sedang	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi
- Area perkantoran - Tanpa pasien/area resiko rendah yang tidak terdaftar dimanapun	- Perawatan pasien dan tidak tercakup dalam grup ¾ - Laundry - Cafeteria - Ruang Gizi - Manajemen material - MRI - Obat-obatan nuklir - Echocardiography	- UGD - Radiologi - Recovery Rooms - Ruang Maternitas / VK - High Dependency Unit - Kamar Bayi - Pediatrics - Lab Microbiologi - Farmasi - Dialisis - Endoskopi	- Unit Onkologi/kanker - Terapi radiasi - Area klinis - Chemo Infusion - Transplant - Pharmacy - Admixture-Ruang Bersih Kamar Operasi - CSSD - Kateterisasi Jantung

	▪ Laboratorium tidak spesifik seperti grub 3 ▪ Koridor umum (yang dilewati pasien, suplai, dan linen)	▪ Area bronchoskopi	▪ Kamar prosedur invasive rawat jalan ▪ Newborn Intensife Care Unit (NICU) ▪ Intensive Care Unit (ICU)
--	--	---	--

4. Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan
- Tabel 10.3 *INFECTION CONTROL MATRIX – LEVEL KEWASPADAAN : PROYEK PEMBANGUNANN DENGAN RESIKO INFEKSI PASIEN JENIS PROYE RENOVASI*

KELOMPOK RESIKO PASIEN	TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D
RESIKO RENDAH	I	II	II	III/IV
RESIKO SEDANG	I	II	III	IV
RESIKO TINGGI	I	II	III/IV	IV
RESIKO SANGAT TINGGI	II	III/IV	III/IV	IV

5. Perencanaan dan intervensi lanjutan
- Tabel 10.4 Perencanaan dan Intervensi berdasarkan Kelas

LEVEL	SELAMA PROYEK PEMBANGUNAN	SETELAH PENYELESAIAN PROYEK
Kelas I	1. Melaksanakan pekerjaan dengan metode yang meminimalkan debu dari lokasi konstruksi. 2. Mengganti plafon yang dilepaskan untuk inspeksi visual sesegera mungkin.	Area kerja bersih setelah pekerjaan proyek selesai.
Kelas II	1. Menyediakan sarana aktif untuk mencegah debu terbang ke dalam atmosfer. 2. Segel pintu yang tidak terpakai dengan lakban. 3. Tempatkan sampah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dipindahkan. 4. Pel basah dan/atau vakum dengan alat vacuum dengan filter HEPA. 5. Tempatkan keset di pintu masuk dan keluar dari area kerja, dan diganti atau dibersihkan ketika sudah tidak efektif. 6. Isolasi sistem HVAC pada lokasi tempat berlangsungnya pekerjaan. 7. Pembersihan area kerja dan permukaan horizontal pada penyelesaian proyek.	1. Bersihkan permukaan kerja dengan lap pembersih yang dibasahi dengan cairan desinfektan. 2. Pengangkutan Limbah renovasi ditempatkan dalam wadah tertutup rapat. 3. Area kerja dibersihkan dengan lap yang dibasahi cairan desinfektan , penyedotan debu atau HEPA Filter. 4. Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.
Kelas III	1. Isolasi sistem HVAC pada lokasi tempat berlangsungnya	1. Jangan menghilangkan hambatan dari area kerja sampai

	pekerjaan untuk mencegah kontaminasi sistem saluran. 2. Lengkapi semua barier konstruksi sebelum konstruksi dimulai. 3. Pertahankan tekanan udara negatif di lokasi kerja menggunakan unit ventilasi dengan filter HEPA atau metode lain untuk mempertahankan tekanan negatif. Keamanan publik akan memonitor tekanan udara. 4. Jangan menghilangkan barier dari area kerja sampai proyek selesai dibersihkan secara menyeluruh. 5. Pel basah atau vakum dua kali per 8 jam pada kegiatan konstruksi, atau sebagaimana diharuskan untuk meminimalkan pelacakan. 6. Buang material barier dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran & debris yg terkait dengan konstruksi. Material barier harus diseka basah, divacum dengan HEPA atau disemprot air sebelum dibuang. 7. Tempatkan sampah konstruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dipindahkan 8. Tempatkan keset di pintu masuk dan keluar dari area kerja, dan diganti atau dibersihkan ketika sudah tidak efektif. 9. Bersihkan area kerja dan permukaan horizontal pada penyelesaian proyek.	proyek selesai setelah diperiksa oleh Tim PPI dan Kepala Proyek. 2. Hapus penutup area renovasi (terpal) secara hati-hati untuk meminimalkan penyebaran debu, kotoran dan puing-puing bangunan. 3. Bersihkan area kerja dengan Vacuum dan disaring dengan HEPA Filter. 4. Area renovasi segera dibersihkan dengan pel yang dibasahi cairan desinfektan. 5. Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.
Kelas IV	1. Isolasi sistem HVAC di area renovasi untuk mencegah kontaminasi. 2. Sebelum pelaksanaan proyek, tutup area dengan penutup plastik / bahan lain yang rapat sehingga tidak ada paparan debu, kotoran dan puing-puing bangunan. 3. Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan memanfaatkan HEPA Filter udara. 4. Tutup semua lubang pintu, pipa, dan saluran. 5. Menyediakan tempat untuk berganti pakaian , memaki APD dan membersihkan badan	1. Jangan melepas penutup area proyek sebelum pekerjaan selesai diperiksa oleh Tim PPI dan Tim pembangunan Rumah Sakit. 2. Lepaskan penutup area renovasi (terpal, plastik atau seng) secara hati – hati untuk meminimalkan kontaminasi debu, kotoran dan puing-puing bangunan. 3. Pengangkutan limbah renovasi ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat. 4. Area kerja dibersihkan dengan vakum dan udara disaring dengan HEPA Filter. Vacuums.

	(mandi) sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan proyek. 6. Semua orang yang memasuki area proyek wajib memakai sepatu tertutup.	5. Bersihkan area bekas renovasi dengan kain pel yang sudah dibasahi cairan desinfektan. 6. Setelah selesai, kembalikan sistem HVAC seperti semula.
--	---	---

Ijin Kerja Dari Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Izin no :					
Lokasi kontruksi :			Tanggal mulai proyek :		
Koordinator proyek :			Perkiraan durasi :		
Sarana-prasarana :					
Pekerjaan kontruksi :			Tanggal Kadaluarsa:		
Supervisor :			Telephone:		
Ya	Tidak	Aktifitas Kontruksi	Ya	Tidak	Kelompok Berisiko
		Tipe A: Inspeksi, aktifitas non invasive			Kelompok 1: Risiko rendah
		Tipe B: Skala kecil, durasi pendek, tingkat sedang-tinggi			Kelompok 2: Risiko sedang
		Tipe C: Kegiatan yang menghasilkan debu tingkat sedang sampai tinggi, membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 1 shift.			Kelompok 3: Risiko tinggi
		Tipe D: Kegiatan kontruksi level tinggi. Membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang.			Kelompok 4: Risiko sangat tinggi
Kelas I		1. Lakukan pekerjaan konstruksi dengan metode debu minimal. 2. Segera mengganti plafon yang digunakan untuk pemeriksaan visual.	1. Pembongkaran minor untuk perombakan ulang.		
Tgl.					
Paraf					
Kelas II		1. Menyediakan sarana aktif (peralatan lengkap) untuk mencegah penyebaran debu ke udara. 2. Memberikan kabut air pada permukaan kerja untuk mengendalikan debu saat proses pemotongan. 3. Menyegel pintu yang tidak terpakai dengan lakban. 4. Menutup ventilasi udara. 5. Bersihkan permukaan kerja dengan pembersih/disinfektan.	1. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 2. Lakukan pengepelan basah dan/atau vakum dengan HEPA filter sebelum meninggalkan area kerja. 3. Letakkan dust mat (keset debu) di pintu masuk dan keluar area kerja. 4. Isolasi sistem HVAC di daerah di mana pekerjaan sedang dilakukan, rapikan kembali setelah pekerjaan selesai.		
Tgl.					
Paraf					

Kelas III	1. Memperoleh perizinan dari KPPI sebelum kegiatan konstruksi dimulai. 2. Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi pada sistem saluran. 3. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai.	1. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA. 2. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan. 3. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi. 4. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 5. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah. 6. Setelah pekerjaan selesai, rapikan kembali sistem HVAC.
Tgl.	4. Menjaga tekanan udara negatif dalam area kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA. 5. Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan.	
Paraf		
Kelas IV	1. Memperoleh perizinan dari KPPI sebelum kegiatan konstruksi dimulai. 2. Mengisolasi sistem HVAC di area kerja untuk mencegah kontaminasi sistem saluran. 3. Siapkan pembatas area kerja atau terapkan metode kontrol kubus (menutup area kerja dengan plastik dan menyegel dengan vakum HEPA untuk menyedot debu keluar) sebelum konstruksi dimulai. 4. Menjaga tekanan udara negatif dalam tempat kerja dengan menggunakan unit penyaringan udara HEPA. 5. Menyegel lubang, pipa, dan saluran. 6. Membuat anteroom dan mewajibkan semua personel untuk melewati ruangan ini sehingga mereka dapat disedot menggunakan vacuum cleaner HEPA sebelum meninggalkan tempat kerja atau mereka bisa memakai pakaian kerja yang lepas setiap kali mereka meninggalkan tempat kerja.	1. Semua personil yang memasuki area kerja diwajibkan untuk memakai penutup sepatu. Sepatu harus diganti setiap kali keluar dari area kerja.Pembatas area kerja harus tetap dipasang sampai proyek selesai diperiksa oleh Komite K3, KPPI, dan dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan. 2. Vakum area kerja dengan penyaring HEPA. 3. Lakukan pengepelan basah dengan pembersih/disinfektan. 4. Lakukan pembongkaran bahan-bahan pembatas area kerja dengan hati-hati untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan puing-puing konstruksi. 5. Letakkan limbah kontruksi dalam wadah yang tertutup rapat sebelum dibuang. 6. Tutup wadah atau gerobak transportasi limbah. 7. Setelah pekerjaan selesai, rapikan kembali sistem HVAC.
Tgl.		
Paraf		
Persyaratan tambahan:		
1. Petugas wajib memakai APD terutama masker saat memasuki area konstruksi. 2. Pastikan area kontruksi tertutup untuk minimalis paparan debu. 3. Pel basah atau vakum dua kali per 8 jam (4 jam sekali) pada kegiatan kontruksi.		

4. Ruang tidak boleh digunakan sebelum dilakukan general cleaning dan desinfeksi ruangan.

Pasuruan,			
Pemberian Ijin PPI/PCN:	Koordinator Proyek:	Ketua K3RS:	Unit IPSRS: (Sarana Prasarana)